

Trastornos Conversivos y Disociativos

Los **trastornos conversivos** y los **trastornos disociativos** son cuadros psiquiátricos frecuentemente gatillados por situaciones de estrés agudo o crónico. Aunque comparten la ausencia de una causa orgánica explicable, se diferencian principalmente en la naturaleza de sus síntomas: neurológicos en la conversión y psicológicos en la disociación.

Trastornos Conversivos

Anteriormente clasificados dentro de los trastornos somatomorfos, los trastornos conversivos se caracterizan por la aparición súbita de síntomas que sugieren una enfermedad neurológica, pero que no tienen una base fisiopatológica orgánica.

Clínica y Presentación

Los síntomas suelen simular un **Accidente Cerebrovascular** o cuadros neurológicos agudos: - **Síntomas motores:** Hemiparesia, paraplejía, afonía o dificultad para hablar. - **Síntomas sensoriales:** Ceguera súbita, sordera, anestesia en "guante" o "calcetín". - **Crisis no epilépticas:** Convulsiones que no siguen un patrón electroencefalográfico (pseudoconvulsiones).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La belle indifférence: Es característico que el paciente con trastorno conversivo se muestre llamativamente tranquilo o poco preocupado frente a la gravedad de sus síntomas (ej. estar ciego y no parecer asustado). Además, en caídas o convulsiones, raramente presentan lesiones físicas graves.

Diagnóstico y Manejo

- El diagnóstico es **100% clínico**, basado en la incongruencia del examen físico con la anatomía neurológica (ej. resistencia al movimiento pasivo en un miembro supuestamente paralizado).
- **Diagnóstico diferencial:** Es vital descartar causas orgánicas. Si el examen neurológico no es absolutamente normal o existen dudas, se debe solicitar neuroimagen (TAC o RM).
 - **Tratamiento:** Educación al paciente, validación de que sus síntomas son reales (no los está inventando voluntariamente) y **psicoterapia** enfocada en el manejo del estrés.
 - **Pronóstico:** Generalmente bueno en cuadros agudos, con baja tasa de recurrencia si se realiza el diagnóstico y manejo adecuado.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Negligencia médica: Nunca asuma que un síntoma es conversivo sin un examen neurológico riguroso. Si existe sospecha de organicidad, el registro clínico debe justificar claramente por qué se omitió o se solicitó una imagen.

Trastornos Disociativos

A diferencia de los conversivos, aquí el síntoma es de índole **psicológica**. Existe una ruptura en la integración de la conciencia, la memoria o la identidad.

Subtipos de Trastornos Disociativos

TABLA 7.20.1: TRASTORNO VS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
TRASTORNO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Amnesia Disociativa	Pérdida de memoria selectiva sobre eventos traumáticos o estresantes.
Fuga Disociativa	Viaje repentino lejos del hogar con pérdida de la identidad previa y amnesia del pasado.
Estupor Disociativo	Inmovilidad extrema y ausencia de respuesta ante un trauma vital grave.
Trastorno de Identidad Disociativa	Presencia de dos o más personalidades; una no recuerda lo que hace la otra.
Despersonalización	Sensación de extrañeza con el propio cuerpo (ej. "mi mano no es mía").
Desrealización	Sensación de que el mundo o el entorno es irreal, como una pesadilla o "de plástico".

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Estos cuadros actúan como mecanismos de defensa ante un estrés insoportable. El cerebro "desconecta" áreas de la conciencia para proteger al individuo del impacto emocional.

El Síndrome de Ganser

Es un cuadro disociativo clásico en entornos carcelarios (reos condenados). Se caracteriza por: - **Pararrespuestas:** Respuestas aproximadas o absurdas a preguntas simples (ej. "¿Cuánto es 2+2?", respuesta: "5"). - Puede acompañarse de alucinaciones y síntomas disociativos.

Diagnóstico Diferencial Clave

- Es fundamental distinguir estos cuadros de otras patologías psiquiátricas:
- **Vs. Psicosis:** En la disociación (despersonalización/desrealización), el paciente mantiene el **juicio de realidad**; sabe que lo que siente es raro o anormal. En la psicosis, el paciente está convencido de su delirio.
 - **Vs. Trastorno Facticio:** En el conversivo/disociativo, el síntoma es **involuntario**. En el facticio, el paciente finge los síntomas deliberadamente para asumir el "rol de enfermo".
 - **Vs. Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT):** El TEPT se caracteriza por la reexperimentación (flashbacks) y evitación. Aunque el TEPT puede tener síntomas disociativos, si predominan los flashbacks y la hiperalerta, el diagnóstico principal es TEPT.

Casos Clínicos y Perlas EUNACOM

- **Caso de Ceguera tras evento emocional:** Siempre sospechar **Trastorno Conversivo**.
- **Paciente que no recuerda un asalto o violación:** Se trata de una **Amnesia Disociativa**.
- **Sensación de vivir en la "Matrix" o en un sueño:** Si el paciente sabe que es una sensación y no una realidad absoluta, es **Desrealización**.
- **Fuga y nueva identidad:** Si encuentran a un paciente vagando lejos de su ciudad y no sabe quién es, piense en **Fuga Disociativa**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerde que el manejo inicial de todos estos cuadros es la **estabilización emocional, educación y derivación a psicoterapia** para abordar el conflicto estresante subyacente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 28 años llega a urgencias tras una fuerte discusión con su pareja. Está con paresia del brazo derecho y no puede hablar. Al examen neurológico se observa que cuando se le levanta el brazo y se suelta, este cae lentamente (no de golpe). La TAC de cerebro es normal. La paciente parece relativamente tranquila. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Conversivos y Disociativos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los trastornos conversivos tienen síntomas neurológicos sin causa orgánica; siempre descartar AVE u otra causa neurológica.
- En los trastornos conversivos el paciente suele estar relativamente tranquilo ante sus síntomas (belle indifférence).
- La amnesia disociativa es pérdida selectiva de memoria en contexto de trauma o estrés agudo; no hay pérdida de juicio de realidad.
- La fuga disociativa: viaje repentino con olvido de la identidad anterior; frecuentemente post-estrés agudo intenso.
- La despersonalización es sensación de que el propio cuerpo es ajeno; la desrealización es sensación de que el mundo no es real; ambas sin psicosis.
- El síndrome de Ganser se caracteriza por "para-respuestas" o respuestas aproximadas; clásico de reclusos.
- Diferencia disociativo vs psicótico: el disociativo sabe que lo que siente es raro y no real; el psicótico tiene certeza absoluta.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS CONVERSIVOS Y DISOCIATIVOS)**PREGUNTA 1**

Mujer de 28 años llega a urgencias tras una fuerte discusión con su pareja. Está con paresia del brazo derecho y no puede hablar. Al examen neurológico se observa que cuando se le levanta el brazo y se suelta, este cae lentamente (no de golpe). La TAC de cerebro es normal. La paciente parece relativamente tranquila. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** ACV isquémico en evolución; trombolisis
- B)** Trastorno conversivo; psicoterapia y manejo del estrés
- C)** Simulación; confrontar a la paciente
- D)** Crisis histérica; haloperidol IM
- E)** Trastorno facticio; derivar a psiquiatría urgente

PREGUNTA 2

Hombre de 40 años es encontrado vagando en un barrio desconocido sin recordar su nombre ni cómo llegó ahí. Dice que "vive en esa ciudad desde siempre". Su familia reporta que desapareció hace 3 días tras perder su empresa en quiebra. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Amnesia disociativa; psicoterapia
- B)** Fuga disociativa; psicoterapia y educación
- C)** Demencia de inicio rápido; evaluación neurológica urgente
- D)** Episodio psicótico breve reactivo; antipsicótico
- E)** Simulación por problemas legales; derivar a carabineros

PREGUNTA 3

Mujer de 35 años refiere que desde hace 2 semanas siente que su mano derecha "no es de ella", que la ve como algo ajeno. Está muy angustiada con esto y dice "sé que suena raro y que probablemente sea algo de mi mente". ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Esquizofrenia; antipsicótico
- B)** Despersonalización; psicoterapia y manejo del estrés
- C)** AVC con déficit de esquema corporal
- D)** Trastorno somatomorfo por dolor
- E)** Delirio de control pasivo; iniciar antipsicótico

RESUMEN: TRASTORNOS CONVERSIVOS Y DISOCIATIVOS

Los trastornos conversivos se caracterizan por síntomas neurológicos súbitos sin causa orgánica, frecuentemente en contexto de estrés. Los ejemplos más comunes son: pérdida de conciencia, crisis pseudocomiciales, ceguera, parálisis, afonía y afasia. Clínicamente el paciente suele estar relativamente tranquilo ante sus síntomas (la belle indifférence) y, cuando se cae, no se golpea fuertemente. Los síntomas no siguen el patrón anatómico de un daño neurológico real. El diagnóstico es clínico pero siempre requiere descartar causa orgánica con neuroimagen o examen neurológico detallado (por responsabilidad médico-legal). El tratamiento es psicoterapia orientada al manejo del estrés subyacente; tienen buen pronóstico si son manejados. Los trastornos disociativos son de índole psicológica (a diferencia de los conversivos que son neurológicos). La causa es el estrés agudo o crónico que lleva a una "disociación" de la conciencia. Los principales son: amnesia disociativa (pérdida de memoria selectiva, frecuentemente post-evento traumático), fuga disociativa (viaje repentino con olvido de la identidad previa), estupor disociativo (inmovilidad ante un trauma), trastorno de identidad disociativa (doble personalidad, muy infrecuente), despersonalización (sensación de que el propio cuerpo es ajeno) y desrealización (sensación de que el mundo no es real). El síndrome de Ganser es infrecuente, clásico de reclusos, con respuestas aproximadas o "para-respuestas". El diagnóstico es clínico; el tratamiento es psicoterapia y educación. La diferencia fundamental entre los trastornos disociativos y los psicóticos es que en los disociativos no hay pérdida del juicio de realidad: la persona sabe que lo que le pasa es raro y que probablemente sea un problema de su mente. El TEPT puede incluir síntomas disociativos pero el diagnóstico principal sigue siendo el TEPT.